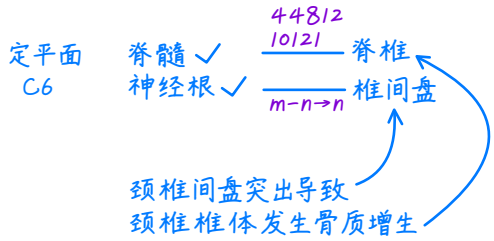
C.减压、内固定手术治疗
D.牵引外固定、平卧硬板床

2.2015N118-120 A 男性，60 岁。左手麻木半年，双下肢乏力，行走不稳三个月。查体：左上肢桡骨膜发射减弱，左手拇指针刺觉减退，双下肢腱反射亢进，双侧 Babinski 征阳性。初步诊断为颈椎病。

118.颈椎病变的平面最可能位于
A.颈 4-5
B.颈 5-6
C.颈 6-7
D.颈 7-胸 1

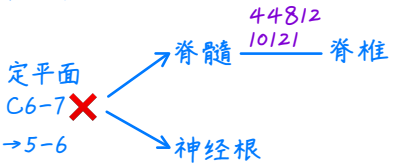


119.对诊断最具价值的影像学检查是
A.B 超
B.X 线
C.增强 CT
D.MRI

120.患者最终确诊为颈椎单一节段的椎间盘突出，相应平面椎管狭窄，颈脊髓变性。对该患者不宜采取的治疗方案是
A.颈椎前后路联合手术
B.颈椎前路手术
C.颈椎后路手术
D.按摩治疗 禁止按摩和颌枕带牵引

3.2008N118-120 A 男性，17 岁。半小时前因跳马比赛不慎颈部受伤，初步检查：患者可主动作肩前屈、肘屈运动，但不能主动作肘伸运动，双下肢软瘫。脊休克期间都为软瘫，2-4周后变为硬瘫

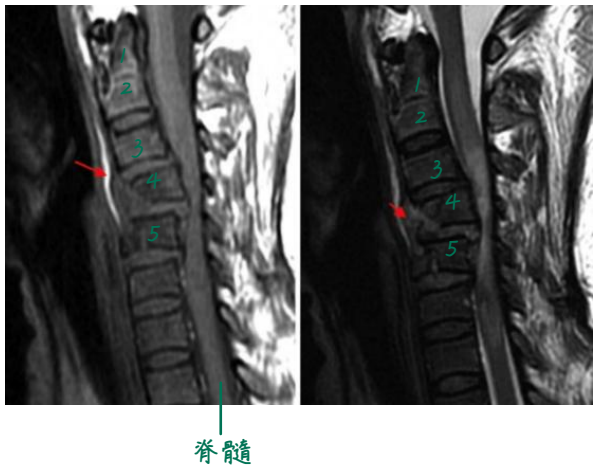
118.该患者损伤部位最可能是位于
A.颈 3、4
B.颈 4、5
C.颈 5、6
D.颈 6、7



临床上说损伤部位多指椎体/椎间盘，不会指脊髓

119.急诊入院后，颈椎 X 线片未见骨折脱位，最适宜的处理是
A.半卧位，减轻腹部对胸腔的压力
B.平卧四头带颈部牵引
C.气管切开、呼吸机辅助呼吸
D.急诊手术探查颈髓损伤程度

无骨折脱位过伸损伤
颅骨牵引固定→扩大椎管容积(后路椎板成形术)
辅助措施
没有脱位，固定避免对脊髓造成二次损害
上颈椎(C1-C4)损伤才需要



120.患者入院后，出现呼吸道感染，最主要的原因是
A.双下肢软瘫
B.肋间肌瘫痪
C.膈肌瘫痪
D.未联合使用抗生素

痰液无法咳出→呼吸道感染
C4